

BỆNH VIỆN PHONG-DÀ LIỄU TW QUY HÒA
KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH



SỔ TAY DỊCH VỤ
KHÁCH HÀNG

Mã tài liệu: XN-STDV

Phiên bản: 2.0

Ngày hiệu lực:.... / 01/ 2026

Gia Lai, tháng 01/ 2026

	BỆNH VIỆN PHONG-DÀ LIỄU TW <u>QUY HÒA</u> KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH	Mã số: XN-STDV <i>Lần ban hành: 02</i> <i>Ngày ban hành:</i> <i>.../01/2026</i> <i>Số trang: 25</i>
	SỔ TAY DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG	

	Người biên soạn	Người xem xét	Người phê duyệt
Họ và tên	CKI.XN.Nguyễn Thái Hòa	Ths.Nguyễn Thị Bình	Ts.Vũ Tuấn Anh
Ký tên			
Chức vụ	KTV.Trưởng khoa	Trưởng khoa	Giám đốc
Ngày	01/01/2026	10/01/2026	.../01/2026

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

TT	Vị trí	Nội dung sửa đổi	Người sửa	Ngày sửa

MỤC LỤC

	Trang
1 Thông tin liên lạc	4
2 Danh mục xét nghiệm, quy cách lấy mẫu, thời gian trả kết quả	
Danh mục xét nghiệm Miễn dịch.....	5
Danh mục xét nghiệm Vi sinh....	8
3 Các quy định chung với mẫu bệnh phẩm	10
4 Một số yêu cầu riêng cho từng loại bệnh phẩm	11
5 Ý nghĩa các xét nghiệm.....	15
6 Bảo quản và vận chuyển mẫu.....	18
7 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.....	19
8 Tiêu chuẩn chấp nhận và từ chối mẫu.....	19
9 Hướng dẫn điền các biểu mẫu.....	20
10 Chỉ định xét nghiệm bổ sung	21
11 Chính sách bảo mật thông tin.....	22
12 Giải quyết khiếu nại.....	22
13 Lưu mẫu và xử lý dụng cụ, chất thải.....	24
14 Tài liệu tham khảo.....	24
<i>Phụ lục: Phiếu trả kết quả xét nghiệm</i>	25

1. Thông tin liên lạc**Bệnh viện: Bệnh viện Phong-Da liễu TW Quy Hòa**

Địa chỉ: 05A Chế Lan Viên, P.Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02563 532 536 - 02563 705 557

Email: quyhoandh2005@gmail.com

Khoa Xét nghiệm: Khoa Vi sinh-Miễn dịch

Điện thoại: 02563 705 1223

Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 07:00 đến 11:30 và 13:30 đến 17:00

Giờ trực: Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 11:30 đến 13:30 và 17:00 đến 7:00 hôm sau

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ: trực 24/24 giờ

Khi cần thông tin về giá dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm:

Liên hệ: Bộ phận chăm sóc khách hàng

Điện thoại: 02563 532 536 - 02563 705 557

Email: quyhoandh2005@gmail.com

Phiên bản: 2.0	Trang 4 / 25
Ngày ban hành:01/2026	

2. Danh mục xét nghiệm, quy cách lấy mẫu, thời gian trả kết quả

- Thời gian trả kết quả trên mạng là khoảng thời gian tính từ lúc nhân viên khoa Vi sinh-Miễn dịch nhận mẫu bệnh phẩm từ điều dưỡng khoa lâm sàng hoặc từ tổ lấy bệnh phẩm, cho tới khi kết quả xét nghiệm được đưa lên phần mềm quản lý bệnh viện.

- Thời gian hẹn trả giấy kết quả xét nghiệm là khoảng thời gian tính từ lúc khoa nhận mẫu bệnh phẩm tới lúc trả giấy kết quả xét nghiệm cho Điều dưỡng lâm sàng và khách hàng sử dụng dịch vụ tại khoa.

+ Đối với xét nghiệm khoa Khám bệnh và các xét nghiệm “cấp cứu” từ các khoa điều trị: trả giấy kết quả ngay sau khi kết quả có trên phần mềm quản lý LIS bệnh viện (thời gian hẹn trả như ở các bảng dưới đây).

+ Đối với xét nghiệm thường quy: trả kết quả sau khi có kết quả trên phần mềm LIS của bệnh viện, nhân viên duyệt trả kết quả ngay trên hệ thống điện tử các vào các giờ hành chính.

- Các xét nghiệm ngoài giờ hành chính: thực hiện khi là các xét nghiệm “Cấp cứu”.

- Các xét nghiệm không trả trong ngày thì khách hàng nhận phiếu hẹn kết quả tùy thuộc vào thời gian của từng loại xét nghiệm.

2.1. Danh mục xét nghiệm Miễn dịch

STT	Xét nghiệm	Quy cách lấy mẫu	Ngày làm xét nghiệm	Thời gian trả KQ trên mạng (với XN phòng khám và XN khẩn)
	MÁU			
	MIỄN DỊCH			
1	Định lượng T3	2,0 mL máu toàn phần, cho vào ống chống đông Heparin	- Giờ hành chính - Ngoài giờ hành chính	≤ 2 giờ
2	Định lượng FT4			
3	Định lượng TSH			
4	Định lượng Cortisol			
5	Định lượng CA-125			
6	Định lượng CA15-3			
7	Định lượng CA 72-4			
8	Định lượng CA 19-9			

<i>STT</i>	<i>Xét nghiệm</i>	<i>Quy cách lấy mẫu</i>	<i>Ngày làm xét nghiệm</i>	<i>Thời gian trả KQ trên mạng (với XN phòng khám và XN khẩn)</i>
9	Định lượng AFP			
10	Định lượng Cyfra 21-1			
11	Định lượng CEA			
12	Định lượng Tg			
13	Định lượng Anti Tg			
14	Định lượng PSA			
15	Định lượng Troponin hs			
16	Định lượng PCT			
17	Định lượng Beta HCG			
18	HBsAg tự động			
19	HBsAb tự động			
20	HBeAg tự động			
21	Anti HCV tự động			
22	Chlamydia Ab tự động			
23	Định lượng IgE (Immunoglobuline E)			
24	Chẩn đoán huyết thanh giun đũa chó (Toxocara canis)	1-2 mL máu cho vào ống chứa nghiệm sạch	- Suất 1: mẫu máu lấy trước 8h30 - Suất 2: mẫu máu lấy trước 9h30 - Suất 3: mẫu máu lấy trước 14h30 - Suất 4: mẫu lấy sau 14h30	- Suất 1: lúc 10h15 - Suất 2: lúc 11h00 - Suất 3: lúc 16h00 - Suất 4: lúc 10h15 sáng của ngày làm việc hôm sau
25	Chẩn đoán huyết thanh giun lươn (Strongyloides stercoralis)			
26	Chẩn đoán huyết thanh giun đầu gai			
27	Chẩn đoán huyết thanh sán gạo heo (Cysticercus cellulosae)			
28	Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch tự động			
29	Chẩn đoán huyết thanh Amibe trong mô			
30	HBsAg test nhanh	1-2 mL máu cho vào ống chứa Heparin hoặc EDTA	Các ngày trong tuần	≤ 60 phút
31	Anti-HBs test nhanh			
32	HBeAg test nhanh			

<i>STT</i>	<i>Xét nghiệm</i>	<i>Quy cách lấy mẫu</i>	<i>Ngày làm xét nghiệm</i>	<i>Thời gian trả KQ trên mạng (với XN phòng khám và XN khẩn)</i>
33	Anti-HCV test nhanh			
34	Helicobacter pylori Ab test nhanh			
35	Viêm gan A (HAV test nhanh)			
36	Viêm gan E (HEV test nhanh)			
37	TB (test nhanh) Phản ứng miễn dịch			
38	Chlamydia test nhanh			
39	Dengue Ag test nhanh			
40	Test sốt xuất huyết IgG/IgM			
41	Malaria P.f/P.v test nhanh			
42	Morphine test nhanh	2-4 ml nước tiểu toàn phần	Các ngày trong tuần	≤ 60 phút
43	Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma túy			
44	Treponema pallidum RPR định tính và định lượng (định tính)	1-2 mL máu cho vào ống chứa nghiệm sạch không có chất chống đông	Các ngày trong tuần	≤ 120 phút
45	Treponema pallidum RPR định tính và định lượng (định lượng)			
46	Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng (định tính)			
47	Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng (định tính)			
48	CRP (C-reactive protein) định tính	1-2 mL máu cho vào ống chứa nghiệm sạch	Các ngày trong tuần	≤ 60 phút
49	CRP (C-reactive protein) định lượng			
50	RF (Reumatoid Factor)			
51	ASLO (Streptococcus pyogens ASO)			
52	53 Dự nguyên			

<i>STT</i>	<i>Xét nghiệm</i>	<i>Quy cách lấy mẫu</i>	<i>Ngày làm xét nghiệm</i>	<i>Thời gian trả KQ trên mạng (với XN phòng khám và XN khẩn)</i>
53	108 Dị nguyên	1,5-2 mL máu cho vào ống nghiệm sạch không có chất chống đông	- Mẫu lấy buổi sáng trước 11h các ngày trong tuần - Mẫu lấy sau 11h và các mẫu buổi chiều	- mẫu trước 11h: trả lúc 16h00 hàng ngày - Mẫu sau 11h: Trả vào 16h00 hôm sau

2.2. Danh mục xét nghiệm Vi sinh

<i>STT</i>	<i>Xét nghiệm</i>	<i>Quy cách lấy mẫu</i>	<i>Ngày làm xét nghiệm</i>	<i>Thời gian trả KQ trên mạng (với XN phòng khám và XN khẩn)</i>
	VI SINH			
1	Đơn bào đường ruột soi tươi	2 gram phân đựng trong lọ sạch	Các ngày trong tuần	≤ 1 giờ
2	Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi			
3	Xét nghiệm KSTĐR			
4	Xét nghiệm soi tươi nấm	Tùy loại bệnh phẩm cần XN	Các ngày trong tuần	< 1 giờ
5	Xét nghiệm Demodex	Tùy loại bệnh phẩm cần XN	Các ngày trong tuần	< 1 giờ
6	AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen	Đờm/mủ/dịch lấy tại nơi nghi ngờ bị lao Đựng trong typ vô trùng	Các ngày trong tuần	≤ 1 giờ
7	Nhuộm Gram	Đờm/mủ/dịch... lấy tại nơi nghi ngờ bị nhiễm trùng Đựng trong typ vô trùng	Các ngày trong tuần	< 1 giờ
8	Định danh vi khuẩn, nấm	Tùy loại bệnh phẩm cần XN	Các ngày trong tuần	5-14 ngày

STT	Xét nghiệm	Quy cách lấy mẫu	Ngày làm xét nghiệm	Thời gian trả KQ trên mạng (với XN phòng khám và XN khẩn)
9	Kháng sinh đồ (kháng thuốc)	Tùy loại bệnh phẩm cần XN	Các ngày trong tuần	2-3 ngày
10	Nuôi cấy bề mặt	Cán bộ khoa XN/khoa KSNK trực tiếp thu thập mẫu	Khi có kế hoạch	2-3 ngày
11	Nuôi cấy dịch họng	Dùng que tăm bông vô trùng ngoáy họng miệng	Các ngày trong tuần	2-3 ngày
12	Nuôi cấy dịch não tủy	Dịch não tủy: 0.5 – 1 ml Đựng trong typ vô trùng	Các ngày trong tuần	2-3 ngày
13	Nuôi cấy dịch ty hầu	Dịch hút mũi họng, dịch nội khí quản (1.5-2ml), que tăm bông ngoáy mũi họng Đựng trong typ vô trùng	Các ngày trong tuần	2-3 ngày
14	Nuôi cấy dịch vô trùng	Dịch tại vị trí nghi ngờ Đựng trong typ vô trùng	Các ngày trong tuần	2-3 ngày
15	Nuôi cấy không khí	Cán bộ khoa XN/khoa KSNK trực tiếp thu thập mẫu	Khi có kế hoạch	2-5 ngày
16	Nuôi cấy mụn	Mụn nơi bị bệnh Đựng trong typ vô trùng hoặc que tăm bông vô trùng	Các ngày trong tuần	2-3 ngày
17	Nuôi cấy nước tiểu	2-3ml nước tiểu Đựng trong typ vô trùng	Các ngày trong tuần	2-3 ngày
18	Nuôi cấy phân	Dùng que tăm bông vô khuẩn ngoáy hậu môn	Các ngày trong tuần	2-3 ngày

3. Các quy định chung với mẫu bệnh phẩm

3.1. Xác định đúng bệnh nhân trước khi tiến hành lấy mẫu

- Tiếp đón, xác định đúng bệnh nhân bằng cách “hỏi” và kiểm tra đối chiếu với các thông tin của bệnh nhân được ghi trong phiếu yêu cầu xét nghiệm và trên hệ thống LIS của bệnh viện.
- Giải thích cho bệnh nhân (hoặc người nhà bệnh nhân) yên tâm và hợp tác.
- Ghi chép đầy đủ, chính xác và không tẩy xóa các thông tin trong phiếu yêu cầu xét nghiệm.
- Thông tin của bệnh nhân: Mã số, họ tên đầy đủ, tuổi (hoặc ngày tháng, năm sinh), giới tính, địa chỉ...
- Thông tin về xét nghiệm: loại xét nghiệm, loại mẫu, chẩn đoán lâm sàng.

3.2. Lấy mẫu bệnh phẩm

- Ghi ngày giờ lấy mẫu, người lấy mẫu trên phiếu chỉ định xét nghiệm.
- Ghi họ tên, tuổi/năm sinh, nơi khám/điều trị của bệnh nhân trên nhãn của ống đựng mẫu bệnh phẩm. Trường hợp nhãn ống mẫu là barcode thì barcode cần có đầy đủ Họ tên bệnh nhân, ngày tháng năm sinh, mã bệnh phẩm...
- Xác định tư thế lấy mẫu cho bệnh nhân vì tư thế lấy mẫu ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật đối với từng loại xét nghiệm yêu cầu.

3.3. Yêu cầu mẫu bệnh phẩm

- Đủ số lượng theo quy định.
- Đựng trong các ống, hộp, lọ phù hợp với từng loại xét nghiệm. Dụng cụ đựng mẫu có nắp đậy kín do Khoa Vi sinh-Miễn dịch cung cấp (Xem thêm phần bảo quản mẫu).
- Trên ống/hộp/lọ đựng phải ghi đầy đủ rõ ràng chính xác: họ tên, tuổi/năm sinh, nơi khám/điều trị; trường hợp nhãn ống mẫu là barcode thì barcode cần có đầy đủ Họ tên bệnh nhân, ngày tháng năm sinh, mã bệnh phẩm...; loại bệnh phẩm (ví dụ: dịch não tủy, mủ vết thương...). Riêng type đựng máu, nước tiểu và phân không cần ghi tên loại bệnh phẩm.
- Bên ngoài ống (hộp, tuýp) đựng phải sạch, không làm rách nhãn.
- Đảm bảo chất lượng mẫu và yêu cầu đối với từng loại xét nghiệm cụ thể.

Phiên bản: 2.0	Trang 10 / 25
Ngày ban hành:01/2026	

- Bệnh phẩm phải được để trong giá và đựng trong hộp vận chuyển kín có nắp đậy khi chuyển tới Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

4. Một số yêu cầu riêng cho từng loại bệnh phẩm

4.1. Bệnh phẩm máu

4.1.1. Thời điểm lấy bệnh phẩm

- Bệnh phẩm máu được chỉ định làm các xét nghiệm Miễn dịch nên được lấy máu vào buổi sáng sớm khi bệnh nhân chưa ăn uống gì.

- Bệnh nhân nên nhịn đói và không dùng các chất kích thích như cà phê, thuốc lá, rượu, bia... 08 giờ trước khi lấy máu (trừ những chỉ định đặc biệt thì thời gian nhịn đói có thể ngắn hơn ví dụ như bệnh nhân cấp cứu hoặc làm một số xét nghiệm có yêu cầu của bác sỹ).

4.1.2. Yêu cầu đối với bệnh phẩm máu

- Thông thường lấy máu tĩnh mạch, một số xét nghiệm thì có thể phải lấy máu mao mạch. Tất cả các kỹ thuật lấy máu đều phải bằng phương pháp vô trùng. Máu được đựng vào các type khác nhau nhằm thu được huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần tùy thuộc vào từng loại xét nghiệm.

- Huyết thanh thu được bằng cách để máu đông tự nhiên trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 1 giờ hoặc ly tâm ở khoảng 3000-4000 vòng/phút trong 5-10 phút, phần dịch nổi (supernatant) phía trên là huyết thanh.

- Huyết tương thu được khi loại ion Ca^{2+} khỏi máu bằng cách thêm vào máu chất chống đông là các chất tạo phức (chelators) để tạo phức với ion Ca^{2+} như EDTA, citrat, oxalat hoặc heparin... dùng cho các xét nghiệm test nhanh miễn dịch.

- Heparin (dưới dạng các muối như amon, Li, Na, K – tuýp nắp màu đen) được sử dụng theo tỷ lệ 25U/mL máu, hay 0,01-0,1 mL heparin/mL máu thường dùng cho các xét nghiệm Miễn dịch chạy máy tự động.

- Máu toàn phần: máu toàn phần (không ly tâm), sử dụng cho xét nghiệm KSTSR, cấy máu...

- Lấy máu làm xét nghiệm theo đúng thứ tự được khuyến cáo như sau:

1. Chai cấy máu
2. Ống không chống đông hoặc ống có các hạt nhựa
3. Ống Heparin (XN Miễn dịch máy tự động)

Phiên bản: 2.0	Trang 11 / 25
Ngày ban hành:01/2026	

4. Ống EDTA (XN KSTSR)

4.2. Bệnh phẩm dịch não tủy

4.2.1. Thời điểm lấy bệnh phẩm

- Bệnh phẩm dịch não tủy là một trong những bệnh phẩm cần thời gian xét nghiệm nhanh để trả kết quả sớm. Vì vậy khi bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ viêm màng não nên được chỉ định chọc dịch não tủy làm xét nghiệm càng sớm càng tốt.

- Lưu ý không nên chỉ định với những bệnh nhân có dấu hiệu gia tăng áp lực nội sọ. Dấu hiệu này được đánh giá qua soi đáy mắt thấy gai thị bị phù nề.

4.2.2. Yêu cầu đối với bệnh phẩm dịch não tủy

- Bệnh phẩm dịch não tủy phải do bác sỹ chuyên ngành trực tiếp chọc dò trong điều kiện vô trùng.

- Thể tích dịch não tủy chọc dò tốt nhất là từ 5-10ml và được chia vào 2 hoặc 3 ống (số lượng ống phụ thuộc số lượng xét nghiệm).

- Loại ống sử dụng là ống vô trùng (với xét nghiệm Vi sinh) có nắp chặt rồi gửi ngay đến phòng xét nghiệm.

- Khi nhận bệnh phẩm dịch não tủy, ngoài thể tích bệnh phẩm, phải chú ý quan sát màu sắc dịch. Nếu dịch bị lẫn ít máu là do quá trình chọc dò bị chạm vào mạch máu. Trừ trường hợp lẫn nhiều máu làm dịch có màu đỏ là do bệnh lý của bệnh nhân (xuất huyết não...).

4.3. Bệnh phẩm dịch ngoáy họng

4.3.1. Thời điểm lấy bệnh phẩm

- Dịch ngoáy họng được chỉ định khi bệnh nhân có các triệu chứng: đau, rát vùng họng. Khám thấy niêm mạc họng sưng đỏ, phù nề, viêm amidan, có màng mủ hay màng giả, phù nề lưỡi, sưng hạch cổ...

- Phải lấy trước khi bệnh nhân dùng kháng sinh toàn thân.

4.3.2. Yêu cầu đối với bệnh phẩm dịch ngoáy họng

Sau khi lấy bệnh phẩm cần chuyển ngay đến Khoa Vi sinh-miễn dịch, không được để tăm bông ngoáy họng bị khô trước khi chuyển đến Khoa.

4.4. Bệnh phẩm đờm

4.4.1. Thời điểm lấy bệnh phẩm

Phiên bản: 2.0	Trang 12 / 25
Ngày ban hành:01/2026	

- Nên chỉ định lấy mẫu đờm trong các trường hợp bệnh nhân có một trong các triệu chứng sau: ho có máu hay ho nhiều, đau ngực, khó thở, có dấu hiệu đặc phổi như có ran ẩm và rít, giảm tiếng rì rào phế nang, gõ đục khi khám phổi, phim phổi có thâm nhiễm, có nang, có mủ...

- Bệnh phẩm được lấy ở giai đoạn càng sớm càng tốt, nên lấy mẫu ngay sau khi có chẩn đoán lâm sàng.

- Nên lấy mẫu trước khi bệnh nhân dùng kháng sinh toàn thân.

4.4.2. Yêu cầu đối với bệnh phẩm đờm

- Trước khi nhận, người kỹ thuật viên phải kiểm tra xem trong bệnh phẩm có đờm hay không. Nếu chỉ toàn nước bọt, phải yêu cầu lấy lại bệnh phẩm ngay.

- Bệnh phẩm đờm phải có dịch đặc, quánh, trắng đục có thể có màu vàng hoặc xanh nhạt, đôi khi có lẫn máu tùy bệnh lý của khách hàng. Nếu chỉ chứa dịch nhớt trong, không màu và lẫn nhiều bọt cần yêu cầu lấy lại bệnh phẩm.

4.5. Bệnh phẩm mủ (mủ áp xe, vết thương nhiễm trùng, nạo mủ xương, mủ ở đường sinh dục...)

4.5.1. Thời điểm lấy bệnh phẩm

- Các trường hợp có mủ như mủ áp xe, vết thương nhiễm trùng, bao gồm các vết loét, lở, mỗ hậu phẫu, loét do nằm lâu, các mẫu nạo mủ xương khi giải phẫu... đều phải được chỉ định cấy mủ tìm căn nguyên gây bệnh.

- Bệnh phẩm mủ với tổ chức mủ kín cần được chọc hút rồi cho vào ống vô trùng có nắp vặn chặt, hoặc để nguyên trong ống kim hút mủ.

- Với các tổ chức mủ hở (vết thương nhiễm trùng...), cần rửa ổ mủ bằng nước muối sinh lý vô trùng và sát trùng các vùng da lành xung quanh bằng cồn 70 độ sau đó có thể lấy tăm bông vô trùng lấy bệnh phẩm ở đáy tổn thương.

- Bệnh phẩm mủ sau khi lấy cần được gửi ngay đến Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

4.5.2. Yêu cầu đối với bệnh phẩm mủ

- Đối với bệnh phẩm mủ đựng trong tube/lọ phải còn nguyên nắp đậy kín.

- Đối với bệnh phẩm mủ lấy bằng tăm bông phải còn nguyên bệnh phẩm, không được để khô.

4.6. Bệnh phẩm nước tiểu

4.6.1. Thời điểm lấy bệnh phẩm

Phiên bản: 2.0	Trang 13 / 25
Ngày ban hành:01/2026	

- Bệnh phẩm nước tiểu dùng để xét nghiệm Chất gây nghiện có thể lấy nước tiểu giữa dòng vào buổi sáng hoặc lấy nước tiểu 24 giờ tùy theo yêu cầu xét nghiệm.

- Đối với xét nghiệm vi sinh nên lấy nước tiểu vào buổi sáng, trong đêm bệnh nhân cố nhịn tiểu cho đến khi lấy mẫu. Có thể lấy nước tiểu giữa dòng vào buổi sáng đối với cây nước tiểu hoặc lấy nước tiểu 24 giờ tùy theo yêu cầu xét nghiệm

4.6.2. Yêu cầu đối với bệnh phẩm nước tiểu

- Nước tiểu nên được lấy vào các lọ vô trùng có nắp đậy hoặc nút bông không thấm nước.

- Nước tiểu sau khi lấy xong phải được gửi đến Khoa Vi sinh-Miễn dịch ngay. Nếu chậm trễ, có thể giữ lạnh ở 4°C nhưng không được quá 2 giờ.

4.7. Bệnh phẩm phân

4.7.1 Thời điểm lấy bệnh phẩm

- Chỉ định xét nghiệm phân khi bệnh nhân bị tiêu chảy hay bị các rối loạn tiêu hóa nghi do bị nhiễm trùng tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa...

- Nên chỉ định cấy phân nếu bệnh nhân có các triệu chứng như: tiêu chảy, lỵ với phân có mủ, nhầy hay máu, bị cơn đau bụng.

- Nên lấy phân vào giai đoạn sớm, càng sớm càng tốt.

- Lấy phân xét nghiệm trước khi sử dụng kháng sinh.

4.7.2. Yêu cầu đối với bệnh phẩm phân

- Bệnh phẩm phân thường dùng trong xét nghiệm Vi sinh và Ký sinh trùng. Xét nghiệm Vi sinh chủ yếu là nhuộm soi, test nhanh và cấy phân. Xét nghiệm Ký sinh trùng chủ yếu là xét nghiệm soi tươi.

- Có thể lấy phân tươi, tốt nhất là vùng có nhầy máu mủ/vùng nghi ngờ bệnh lý, cho vào lọ sạch, rộng miệng, không chứa chất sát khuẩn, hóa chất ức chế/tiêu diệt vi khuẩn. Phân tươi phải được cấy trong vòng không quá 2 giờ sau khi lấy mẫu.

- Có thể lấy mẫu phân bằng tăm bông qua đường hậu môn.

4.8. Bệnh phẩm dịch (dịch rửa phế quản, dịch màng phổi, dịch màng bụng...)

4.8.1. Thời điểm lấy bệnh phẩm

- Khi bệnh nhân sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân, có triệu chứng nhiễm trùng hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc và thăm khám, chẩn đoán hình ảnh thấy có dịch ở khoang màng phổi, khoang màng bụng...

Phiên bản: 2.0	Trang 14 / 25
Ngày ban hành:01/2026	

- Chọc hút dịch trước khi bệnh nhân dùng kháng sinh toàn thân.

4.8.2. Yêu cầu đối với bệnh phẩm dịch

- Bệnh phẩm dịch (dịch rửa phế quản, dịch màng phổi, dịch màng bụng..) phải do bác sỹ chuyên khoa trực tiếp chọc dò trong điều kiện vô trùng.
- Thể tích dịch chọc dò tốt nhất là từ 3-5ml và được cho vào tube vô trùng có nắp chặt, ghi rõ loại dịch rồi gửi ngay đến Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

5. Ý nghĩa lâm sàng các xét nghiệm

5.1. Xét nghiệm Vi sinh-Miễn dịch

STT	Xét nghiệm	Ý nghĩa lâm sàng
	VI SINH	
1	Hồng cầu trong phân test nhanh	Giúp xác định sự có mặt của hồng cầu trong phân, như trong chảy máu đường tiêu hoá...
2	Đơn bào đường ruột soi tươi	Chẩn đoán giun đũa, giun móc, giun tóc, sán...
3	Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi	Tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân
4	AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen	Tìm vi khuẩn kháng cồn kháng acid
5	Nhuộm Gram	Xác định hình thể, tính chất bắt màu và số lượng của vi khuẩn
6	Định danh vi khuẩn/nấm	Xác định tên vi khuẩn/nấm gây bệnh
7	Kháng sinh đồ (kháng thuốc)	Xác định sự kháng kháng sinh của vi khuẩn / nấm
8	Nuôi cấy bề mặt	Xác định sự nhiễm bẩn bề mặt
9	Nuôi cấy dịch họng	Xác định vi khuẩn liên cầu A
10	Nuôi cấy dịch não tủy	Xác định tác nhân gây viêm não, màng não
11	Nuôi cấy dịch tỵ hầu	Xác định căn nguyên gây viêm phổi
12	Nuôi cấy dịch vô trùng	Xác định vi khuẩn, nấm gây bệnh
13	Nuôi cấy không khí	Xác định môi trường không khí tốt hay không
14	Nuôi cấy mủ	Xác định vi khuẩn, nấm gây bệnh
15	Nuôi cấy nước tiểu	Xác định vi khuẩn, nấm gây viêm tiết niệu.

STT	Xét nghiệm	Ý nghĩa lâm sàng
16	Nuôi cấy phân	Xác định vi khuẩn, nấm gây viêm đường tiêu hóa.
17	HBe Ag miễn dịch tự động	Kháng nguyên nhân virus viêm gan B
18	HBsAb miễn dịch tự động	Tìm HBsAb của virus viêm gan B
19	HBsAg miễn dịch tự động	Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B
20	HCV Ab miễn dịch tự động	Kháng thể kháng lại kháng nguyên virus viêm gan C
21	Định lượng T3	Xét nghiệm tuyến giáp
22	Định lượng FT4	Xét nghiệm tuyến giáp
23	Định lượng TSH	Xét nghiệm tuyến giáp
24	Định lượng Cortisol	Định lượng Cortisol máu
25	Định lượng CA-125	Chẩn đoán ung thư buồng trứng
26	Định lượng CA15-3	Chẩn đoán ung thư vú
27	Định lượng CA 72-4	Chẩn đoán ung thư dạ dày
28	Định lượng CA 19-9	Chẩn đoán ung thư tụy
29	Định lượng AFP	Chẩn đoán ung thư gan
30	Định lượng Cyfra 21-1	Chẩn đoán ung thư phổi
31	Định lượng CEA	Chẩn đoán ung thư tế bào biểu mô
32	Định lượng Tg	Chẩn đoán ung thư tuyến giáp
33	Định lượng Anti Tg	Chẩn đoán ung thư tuyến giáp
34	Định lượng PSA	Chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến
35	Định lượng Troponin hs	Chẩn đoán nhồi máu cơ tim
36	Định lượng PCT	Chẩn đoán nhiễm trùng
37	Định lượng Beta HCG	Chẩn đoán thai
38	Chlamydia Ab tự động	Chẩn đoán chlamydia máy miễn dịch tự động
39	Định lượng IgE (Immunoglobuline E)	Chẩn đoán dị ứng
40	Chẩn đoán huyết thanh giun đũa chó (Toxocara canis)	Chẩn đoán giun đũa chó
41	Chẩn đoán huyết thanh giun lươn (Strongyloides stercoralis)	Chẩn đoán giun lươn
42	Chẩn đoán huyết thanh giun đầu gai	Chẩn đoán giun đầu gai

STT	Xét nghiệm	Ý nghĩa lâm sàng
43	Chẩn đoán huyết thanh sán gạo heo (<i>Cysticercus cellulosae</i>)	Chẩn đoán sán gạo heo
44	Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch tự động	Chẩn đoán sán lá gan
45	Chẩn đoán huyết thanh Amibe trong mô	Chẩn đoán amips
46	HBsAg test nhanh	Kháng nguyên bề mặt viêm gan B
47	Anti-HBs test nhanh	Kháng thể viêm gan B
48	HBeAg test nhanh	Kháng nguyên nhân virus viêm gan B
49	Anti-HCV test nhanh	Kháng thể kháng lại kháng nguyên virus viêm gan C
50	Helicobacter pylori Ab test nhanh	Kháng thể vi khuẩn dạ dày
51	Viêm gan A (HAV test nhanh)	Viêm gan A
52	Viêm gan E (HEV test nhanh)	Viêm gan E
53	TB (test nhanh) Phản ứng miễn dịch	Chẩn đoán lao
54	Chlamydia test nhanh	Chẩn đoán chlamydia
55	Dengue virus IgM/IgG test nhanh	Chẩn đoán nhiễm sốt xuất huyết
56	Dengue virus NS1Ag test nhanh	Chẩn đoán nhiễm sốt xuất huyết
57	Malaria P.f/P.v test nhanh	Chẩn đoán sốt rét
58	Morphine test nhanh	Chẩn đoán 1 chất gây nghiện
59	Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma túy	Chẩn đoán 5 chất gây nghiện
60	Treponema pallidum RPR định tính và định lượng (định tính)	Chẩn đoán giang mai
61	Treponema pallidum RPR định tính và định lượng (định lượng)	Chẩn đoán giang mai
62	Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng (định tính)	Chẩn đoán giang mai
63	Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng (định lượng)	Chẩn đoán giang mai
64	CRP (C-reactive protein) định tính	Chẩn đoán viêm định tính
65	CRP (C-reactive protein) định lượng	Chẩn đoán viêm định lượng
66	RF (Rheumatoid Factor)	Chẩn đoán và theo dõi viêm khớp dạng thấp

STT	Xét nghiệm	Ý nghĩa lâm sàng
67	Streptococcus pyogenes ASO	Chẩn đoán viêm khớp, thấp khớp, thấp tim, nhiễm trùng liên cầu
68	53 Dị nguyên	Chẩn đoán 53 dị nguyên
69	108 Dị nguyên	Chẩn đoán 108 dị nguyên

6. Bảo quản và vận chuyển mẫu

6.1. Bảo quản mẫu tại khoa lâm sàng

Mẫu bệnh phẩm lấy xong cần chuyển ngay đến khoa Xét nghiệm càng sớm càng tốt, tối đa:

- Không quá 15 phút đối với các mẫu nuôi cấy.
- Không quá 30 phút đối với xét nghiệm còn lại.

6.2. Cách đóng gói và vận chuyển mẫu

6.2.1. Trong nội bộ bệnh viện

- Ống/lọ đựng bệnh phẩm được đậy nắp kín và xếp vào giá phù hợp kích thước theo chiều thẳng đứng.

- Để giá bệnh phẩm vào hộp vận chuyển kín có nắp đậy và quai xách. Ngoài hộp dán biểu tượng nguy hiểm sinh học. Có thể chèn thêm vật liệu nhằm cố định giá đựng mẫu trong quá trình vận chuyển nhưng không có tác động lên mẫu.

- Phiếu chỉ định xét nghiệm phải được đặt trong ngăn tách rời với mẫu bệnh phẩm (tránh tiếp xúc với mẫu bệnh phẩm, có thể cầm tay hoặc đựng trong các túi bấm)

- Phiếu chỉ định xét nghiệm đặt trong ống vận chuyển cùng với mẫu bệnh phẩm nhưng cần tránh tiếp xúc trực tiếp với mẫu bệnh phẩm

6.2.2. Gửi mẫu tới các phòng xét nghiệm bên ngoài

- Bệnh phẩm phải được đóng gói đảm bảo an toàn sinh học, nhất là những loại bệnh phẩm có nguy cơ lây nhiễm cao thì bệnh phẩm phải được đóng gói vận chuyển 3 lớp:

+ Lớp thứ 1: Ống/lọ chứa mẫu trực tiếp

Ống phải chắc chắn và có nắp kín. Đảm bảo nắp ống đựng mẫu không bị kênh khi chứa mẫu và phải có thông tin nhận dạng trên ống (tên, tuổi và ngày lấy mẫu).

+ Lớp thứ 2: Hộp/túi chứa các ống đựng mẫu

Phiên bản: 2.0	Trang 18 / 25
Ngày ban hành:01/2026	

Hộp/túi phải chắc chắn, kín tuyệt đối và có khả năng hấp thụ dung dịch nếu ống mẫu bị đổ/vỡ.

+ Lớp thứ 3: Thùng/hộp chứa các hộp có ống mẫu bệnh phẩm (thùng nên là loại có lớp vỏ xốp và lớp vỏ bì cứng bên ngoài).

Thùng phải chắc chắn, có khả năng cách nhiệt. Khi vận chuyển mẫu phải đảm bảo thùng chứa bệnh phẩm phải được đặt chắc chắn, tránh va đập.

Bên ngoài thùng có thể đính kèm phiếu yêu cầu xét nghiệm (không để chung phiếu với bệnh phẩm) hoặc có thể để giữa lớp vỏ xốp và lớp vỏ bì cứng (đặt trên nắp thùng xốp rồi mới đóng lớp bì cứng).

Khi gửi bệnh phẩm từ nơi này sang nơi khác trong nước hoặc ra quốc tế, cần bảo quản bệnh phẩm trong phích đá khô. Nói chung, sự thay đổi hoạt độ enzym và nồng độ các chất chuyển hoá không quá $\pm 10\%$ trong khoảng 2 ngày, nếu nhiệt độ bảo quản mẫu dưới 25°C .

Cần thiết liên hệ trước với phòng xét nghiệm bên ngoài để có các thông tin chi tiết về cách chỉ định, thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu.

7. Các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm

- Sau khi ăn, nồng độ các chất glucose, cholesterol, triglycerid, các acid amin, sắt và phosphate tăng lên trong máu.

- Sự thay đổi tư thế bệnh nhân đột ngột khi lấy máu có thể ảnh hưởng đến nồng độ các huyết cầu và các đại phân tử như các bạch cầu, hồng cầu, hemoglobin, hematocrit, protein toàn phần, các enzym, các lipoprotein và các ion gắn protein (như calci, sắt, ...).

- Một số thuốc sử dụng có thể ảnh hưởng đến kết quả một số xét nghiệm.

- Giá trị một số chất có thể thay đổi trong ngày, ví dụ như: các hormon (như cortisol, prolactin, testosterone), các chất điện giải trong nước tiểu, nồng độ hemoglobin và sắt, kẽm trong máu...

- Việc lấy mẫu phải luôn được thực hiện trong những điều kiện chuẩn, nghĩa là khi cách xa bữa ăn, với cùng một tư thế (ngồi hoặc nằm nghiêng), trong khoảng cùng thời gian trong ngày và sau khi buộc garô.

8. Tiêu chuẩn chấp nhận và từ chối mẫu

8.1. Tiêu chuẩn chấp nhận mẫu

- Ống mẫu phù hợp với loại xét nghiệm.

Phiên bản: 2.0	Trang 19 / 25
Ngày ban hành: .../01/2026	

- Trên ống có đầy đủ thông tin theo quy định.
- Ống đựng mẫu có đủ lượng mẫu theo quy định, nắp được đậy chặt, không rò rỉ
- Được vận chuyển theo quy định trong hộp chuyên.
- Giấy chỉ định xét nghiệm có đầy đủ thông tin theo quy định.

8.2. Tiêu chuẩn từ chối mẫu

Mẫu bệnh phẩm có thể bị từ chối ngay khi được tiếp nhận hoặc sau khi được xử lý và chuyển tới các khu vực xét nghiệm trong khoa nếu vi phạm một trong các tiêu chí sau:

- Mẫu máu bị huyết tán.
- Ống mẫu không phù hợp với chỉ định xét nghiệm.
- Thẻ tích lấy không đúng theo quy định.
- Trên ống không có đủ các thông tin quy định.
- Không có giấy chỉ định xét nghiệm.
- Trên giấy không ghi đầy đủ các thông tin yêu cầu, không có chữ ký Bác sỹ chỉ định.
- Thời gian trì hoãn gửi mẫu quá mức quy định.
- Không vận chuyển bằng hộp chuyên dụng.

Lưu ý: Trường hợp bệnh nhi khó lấy mẫu hoặc xét nghiệm “khẩn”, có thể vẫn chấp nhận các mẫu bệnh phẩm huyết tán hoặc thẻ tích không đủ hoặc thời gian trì hoãn gửi mẫu quá mức quy định, nhưng phải ghi chú trên giấy trả kết quả xét nghiệm.

9. Hướng dẫn điền các biểu mẫu

9.1. Hướng dẫn điền phiếu chỉ định xét nghiệm

- Trên phiếu chỉ định cần có đầy đủ các thông tin về bệnh nhân theo quy định (do phần mềm quản lý bệnh viện cập nhật tự động từ bệnh án của bệnh nhân khi bác sỹ chỉ định xét nghiệm). Tham khảo Phụ lục 1 dưới đây.
- Ghi ngày và giờ lấy mẫu, tên người lấy mẫu
- Chữ ký của bác sỹ chỉ định
- Nếu có sử dụng barcode: dán tờ barcode tương ứng với barcode trên ống mẫu lên giấy chỉ định xét nghiệm

9.2. Hướng dẫn điền thông tin bệnh nhân trên ống mẫu

9.2.1. Nếu không sử dụng barcode

Phiên bản: 2.0	Trang 20 / 25
Ngày ban hành:01/2026	

- Trên ống mẫu phải có đầy đủ tối thiểu 3 thông tin của bệnh nhân:
 - + Họ và tên đầy đủ của bệnh nhân, không viết tắt.
 - + Tuổi hoặc năm sinh.
 - + Buồng hoặc khoa điều trị.
 - Thông tin bệnh nhân cần ghi bằng bút không phai.
 - Đối với ống mẫu có dán sẵn giấy viết thì ghi thông tin bệnh nhân lên giấy.
- Với những ống mẫu không dán sẵn giấy: có thể viết trực tiếp lên ống hoặc viết lên một tờ giấy khác và dán vào ống.
- * Chú ý: không dập xóa, không viết đè chữ.

9.2.2. Nếu có sử dụng barcode

- Barcode do cán bộ khoa lâm sàng hoặc tổ bệnh phẩm dán lên ống mẫu trước khi thu thập mẫu
- Vị trí dán barcode trên ống mẫu: dán chiều dọc của barcode theo chiều dọc của ống mẫu, cần để khoảng trống trên ống mẫu để có thể quan sát được tính chất bệnh phẩm đựng bên trong ống. Nếu ống mẫu có dán sẵn giấy (như ống Heparin, EDTA, Citrat) thì dán barcode đè lên giấy dán sẵn đó
- Các thông tin trên tờ barcode tối thiểu cần có: họ tên bệnh nhân, ngày tháng năm sinh, mã bệnh phẩm...

10. Chỉ định xét nghiệm bổ sung

10.1. Chỉ định xét nghiệm bằng lời

Khoa Xét nghiệm không chấp nhận các chỉ định xét nghiệm bằng lời, trong trường hợp có yêu cầu bổ sung xét nghiệm xin xem mục 10.3.

10.2. Chỉ định xét nghiệm qua điện thoại

Chỉ áp dụng khi có yêu cầu bổ sung xét nghiệm

10.3. Chỉ định xét nghiệm bổ sung

Trong trường hợp bác sỹ cần yêu cầu xét nghiệm bổ sung trên cùng một mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến phòng xét nghiệm:

- Bác sỹ hoặc điều dưỡng được chỉ định sẽ thông báo cho bộ phận xét nghiệm có liên quan về xét nghiệm cần bổ sung.
- Bộ phận xét nghiệm sẽ kiểm tra thể tích mẫu và thời gian lưu giữ mẫu còn trong điều kiện cho phép để thực hiện xét nghiệm bổ sung hay không.

Phiên bản: 2.0	Trang 21 / 25
Ngày ban hành:01/2026	

Nếu thời gian lưu giữ mẫu đã quá hạn, nhân viên xét nghiệm có trách nhiệm trả lời ngay cho bác sỹ. Nếu có thể, xét nghiệm bổ sung sẽ được làm trên một mẫu mới.

Nếu điều kiện và thời gian lưu giữ mẫu còn cho phép, đề nghị bác sỹ gửi phiếu chỉ định các xét nghiệm bổ sung tới phòng xét nghiệm.

Những xét nghiệm bổ sung phải là những xét nghiệm nằm trong danh mục các xét nghiệm trong cuốn sổ tay này. Nếu yêu cầu những xét nghiệm bổ sung ngoài danh mục, bác sỹ hoặc điều dưỡng được chỉ định nên liên lạc với các bộ phận xét nghiệm khác để tham khảo ý kiến.

10.4. Lặp lại xét nghiệm

Trong trường hợp bác sỹ có yêu cầu lặp lại xét nghiệm trên cùng một mẫu bệnh phẩm vì có 1 lỗi nào đó trong kết quả xét nghiệm hay để khẳng định hơn trong chẩn đoán điều trị, bác sỹ cần thông báo cho bộ phận xét nghiệm liên quan về lý do cần lặp lại xét nghiệm. Phụ trách bộ phận hay kỹ thuật viên trưởng có trách nhiệm kiểm tra lại mẫu bệnh phẩm và nếu có thể sẽ tiến hành xét nghiệm lại.

11. Chính sách bảo mật thông tin

- Tuân thủ quy định về Y Đức ban hành theo quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 6 tháng 11 năm 1996 của Bộ Trưởng Bộ Y tế.

- Bảo mật thông tin: những thông tin cần bảo mật bao gồm:

+ Thông tin cá nhân và kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.

+ Không tiết lộ các thông tin mật trừ khi có yêu cầu của Lãnh đạo khoa theo chỉ đạo của Lãnh đạo bệnh viện.

+ Kết quả xét nghiệm được trả cho cán bộ khoa lâm sàng. Chỉ trả kết quả trực tiếp cho bệnh nhân hoặc người được ủy quyền đối với 1 số xét nghiệm đặc biệt

+ Chỉ QLCL, QLKT và những người được ủy quyền mới được truy cập và sửa đổi hệ thống thông tin điện tử của Khoa.

+ Khi hủy thông tin, phải đảm bảo thông tin không có khả năng phục hồi.

- Tất cả lãnh đạo, nhân viên phải đọc và hiểu rõ nội dung bản cam kết bảo mật thông tin và đảm bảo chất lượng công việc trước khi ký cam kết và phải tuân thủ đúng nội dung đã cam kết.

12. Giải quyết khiếu nại

12.1. Tiếp nhận khiếu nại

Phiên bản: 2.0	Trang 22 / 25
Ngày ban hành:01/2026	

- Bệnh nhân và người sử dụng dịch vụ xét nghiệm có thể trực tiếp khiếu nại về hoạt động của Khoa Vi sinh-miễn dịch với nhân viên/lãnh đạo Khoa Vi sinh-Miễn dịch.
- Hình thức khiếu nại có thể là công văn, fax, điện thoại hoặc gặp trực tiếp
- Khi Bệnh nhân và người sử dụng dịch vụ xét nghiệm khiếu nại trực tiếp hay gián tiếp thì người tiếp nhận ghi nội dung vào phần tiếp nhận khiếu nại của “Biên bản giải quyết khiếu nại”, mã số XN-BM và “Sổ theo dõi khiếu nại” mã số XN-BM

12.2. Giải quyết khiếu nại

- Lãnh đạo Khoa Vi sinh-Miễn dịch trực tiếp hoặc chỉ định cán bộ xem xét nội dung khiếu nại và điều tra tìm nguyên nhân, bằng chứng.
 - Nếu khiếu nại không chính xác hoặc phát hiện có sai sót nhưng không phải do Khoa Vi sinh-Miễn dịch gây ra, người giải quyết khiếu nại phải thu thập các bằng chứng cụ thể để giải thích cho người khiếu nại.
 - Nếu phát hiện sai sót/sự không phù hợp từ phía Khoa Vi sinh-Miễn dịch, người giải quyết khiếu nại cần đề xuất các giải pháp phù hợp.
 - Từ các phát hiện và bằng chứng thu thập được, người giải quyết khiếu nại điền các thông tin vào phần Giải quyết khiếu nại của “Biên bản giải quyết khiếu nại” và các biện pháp giải quyết khiếu nại nếu cần thiết. Trên cơ sở đó Khoa Vi sinh-Miễn dịch sẽ trao đổi với người khiếu nại và thống nhất cách thức giải quyết.
 - Người khiếu nại ký xác nhận đồng ý hoặc không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại. Nếu người khiếu nại không đồng ý thì Khoa Vi sinh-miễn dịch phải lập tiếp “Biên bản giải quyết khiếu nại”.
- Nếu khách hàng khiếu nại gián tiếp (email, Zalo, điện thoại...) không trực tiếp ký vào biên bản thì cán bộ giải quyết khiếu nại sẽ ghi vào phần “xác nhận của khách hàng” khiếu nại đã được giải quyết.
- Trong quá trình giải quyết khiếu nại nếu phát hiện có sự không phù hợp, Khoa Vi sinh-Miễn dịch lập mã số cho sự không phù hợp và giải quyết theo quy trình “Kiểm soát sự không phù hợp”.

12.3. Trả lời khiếu nại của khách hàng

- Khi có kết quả giải quyết khiếu nại, lãnh đạo Khoa Vi sinh-Miễn dịch hoặc người được chỉ định phải thông báo cho người khiếu nại bằng văn bản hoặc trả lời trực tiếp. Nếu

Phiên bản: 2.0	Trang 23 / 25
Ngày ban hành:01/2026	

người khiếu nại chưa hài lòng với kết quả giải quyết khiếu nại, Khoa Vi sinh-Miễn dịch và người khiếu nại sẽ thống nhất các biện pháp giải quyết khác.

- Nội dung thống nhất giữa Khoa Vi sinh-Miễn dịch và người khiếu nại cần được ghi lại vào “Biên bản giải quyết khiếu nại”

13. Lưu mẫu và xử lý dụng cụ, chất thải

- Mẫu bệnh phẩm sau khi thực hiện xét nghiệm được lưu trữ tại khoa Vi sinh-Miễn dịch theo “Quy trình lưu và tiêu hủy bệnh phẩm” mã số XN-QTQL

- Toàn bộ trang phục bảo hộ cùng với các dụng cụ bẩn sau khi lấy mẫu được cho vào thùng đựng rác thải y tế.

- Rửa tay bằng xà phòng chuyên dụng hoặc sát khuẩn nhanh.

* Tham khảo thêm Thông tư 20/2021/TT-BYT, quy định chi tiết việc phân loại, thu gom, lưu trữ và quản lý chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế, phân loại theo màu sắc (vàng, đen, xanh, trắng) và đặc tính nguy hại, lây nhiễm để quản lý riêng biệt.

14. Tài liệu tham khảo

- “Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng” – Nhà xuất bản y học 2013.

- Trần Hữu Tâm (2017). “Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa theo tiêu chuẩn ISO 15189”, NXB Y học.

- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.

- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.

Phiên bản: 2.0	Trang 24 / 25
Ngày ban hành:01/2026	

PHỤ LỤC : MẪU PHIẾU TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN
Địa chỉ.....
SĐT:



Mẫu số:
Hồ sơ:
Số phiếu:

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Họ và tên:

Loại mẫu:

Ngày sinh: Tuổi:

Loại XN:

Giới tính:

Thời gian nhận mẫu:

Địa chỉ:

Người nhận mẫu:

Khoa:

Tình trạng mẫu:

Bác sĩ chỉ định:

Người thực hiện:

Chẩn đoán:

1. Xét nghiệm Hóa sinh máu

STT	Xét nghiệm	Kết quả	Đơn vị	Giá trị tham chiếu	QTKT	Ghi chú

..... Ngày tháng năm

KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH